

2018 年 6 月 9 日（土）

GTA 3 期マスター 第 2 教程

小林和哉

本題に入る前に KAZ KOBAYASHI : 右側尺側N領域の痺れ（右上肢、手術歴2度）

尺側の痺れ = 手根幹SYD(チネルサイン)と一致 = B2 レバーアーム逆側、肘も伸びない
ドゥッケルバン(フィンケルシュタイン) = B2 レバーアームと同側



B2 体操をしてあげると良い (基本は骨盤の治療から順序立てて)

施術時、カウントする + 誘導する

- 肘の伸展ができないのがPI-t側
- 肘が伸びたまま屈曲ができないのがAS側

- 膝の伸展障害 → PI-t
- 膝の屈曲障害 → AS

恥骨のクランク運動が出来ていない

※レバーアーム

非荷重、力が入らない状態を生む

補助診断（前編）

診断率95% あくまでも補助

(しかし基本診断と合わせてより正確に診断するためのもの)

診断率100%の基本診断は7個

診断 それ以外の要素（残りの5%）

- 骨折
- 捻挫
- やけど
- アトピー
- 他の筋幕の影響
- 何回もカイロを受けた (B2テストでピンと筋がでる)
- バキバキ整体治療
- 自分で首を鳴らす (顔色が悪くなる→思考回路が乱れあほになる)
etc...

骨盤、レバーアームの状態を診断する

形式的に治療をやれば良いというものではない

考えずにとりあえず潤滑は駄目



難しい症状だと、このやり方だと改善してこない。

しっかり診断をとって見立てを立てて治療することが大事

診断がはっきりしない、わからない症状に対してなんとやっていると行き当たりばったりの治療になってしまう。ギャンブル的な治療になり時間とお金の無駄になってしまう可能性大！！

関節を鳴らす行為

e. g.) 指をバッキッと鳴らす → 関節が太くなる

キャビテーションエロージョン

パキッと音が鳴った時に関節内に陰圧側と陽圧側の差が生まれる

↓

キャビテーションが発生

約3トンの衝撃がかかり関節が侵食される（波面波）

関節を強制的に（バッキと鳴らして）離す

一瞬にして強い衝撃を与えて、落とすから楽になったと脳が錯覚する

（一旦閾値が上がり、下がると楽になる）→この感覚が忘れなくなり、繰り返してしまう

バイク、自転車を与える骨盤への影響

→振動で離開→ AS

→衝撃で Pit

特にカブはサスが弱く、
ダメージが蓄積しやすい

疾病形成因子



長母趾伸筋筋力抵抗テスト

名前の通り長母趾伸筋の抵抗を診るテスト

脳→脊髄→長母趾 の順で本来は 100 → 100 で届くが
100→50 だったりするようなら出力の問題か伝達障害がある

どこで問題が発生しているか？

1. 脳の問題 （脳血管）
2. 末梢部の問題（変形、骨折、外傷 etc...）
3. 通路の問題（伝達がうまくいってない）
 - 95%～98% WB 由来
 - 2～5% 各移行部の問題

※ 一般的には1つの検査で90%を超える診断技術は病院でもない
最高で血沈検査で60%程度

※ 非荷重状態は膨張することで菌、ウィルスに感染しやすくなる
水虫は非荷重、かかと重心で起こる → なぜなら血流が悪くなるから

手順

1. ベッド中央で患者さんに仰向けになってもらう
2. 患者さんの両膝関節を屈曲し、術者は臀部に手を添え、一旦上げて、そっと下ろす（平行におろす、腰仙部での回旋をとる）
3. 患者さんに両膝関節を**自動**で伸展してもらう
4. 足関節の内外旋を**自動**でなおしてもらう（大腿部から直してもらう）
5. 足関節を90度にしてもらい、術者の膝を患者さんの足底にあてがい、術者は母指に指をあてる → 患者さんに母指を背屈してもらう
6. 患者さんの母指を上げた時の動きを見て感じ取る



2回目: スピードが分かる

1回目: トルクが分かる

力が入っていると普段歩けていることが分かる
→ 荷重できている

長母趾伸筋筋力抵抗テスト 診るべきポイント

1. 反応時間

スーと上がるかどうか？ 反応する時間に左右差はないか？

→脳の問題？ 、転びやすい、原始反射の低下

2. 異常な挙動

スムーズに上がるかどうか？スーと上がるか？ カクカク上がるか？

ガクガクと上がるか？

→力強さ・CGW を見る

3. 加速度

どういうタイプか？シュッと速いのか？

→初速のみ速い：最近、歩き始めた人

→終速のみ速い：昔は歩いていた、今は歩いていない

→全体的に遅い：歩いていない、ケガ、神経麻痺

注意点

※ 足がベッドからはみ出してもよい

※ あくまで抵抗、あまり力を入れすぎないように行うことで細かい情報が得られる

※ 初めの1、2回で見極める = 頭で修正・潤滑もするので結果が違ってくる

何を基準にしてテストを行うのか？

左右差？他の人と比べて？



多く臨床経験が必要

～5年、まず量をこなせ

5年～、質を追求していく

多く診る、多く練習する

HIPテストと一緒にを行う

HIPテストであたりをつけて、長母趾テストを組み合わせることで診断精度が高まる

CGW（コグホイール）について

- 伝達系経路に外傷があるかどうか？
- 挙動：母指の上がり方がカクカクと力が加わり、抜けるという動き
歯車の一部が欠損してカクンと抜ける感覚（ミニ四駆のギアのイメージ）
伝達が早くなっている状態

外傷部位は主に WB だが、足関節、膝、股関節、脊椎とどの関節でもみられる

陽性の場合は同側に外傷があったとみなす（≠Pit、AS）

捻挫や外傷があったということがわかるということ

捻挫がある場合は

- まず患者さんに聞くこと
- 足関節伸展位で捻挫領域を押す → 圧痛

歩行により捻挫のような状態になる場合がある（前距腓靱帯の圧痛）

股関節が内旋 — Pit 傾向



足首が内旋



前距腓靱帯が伸びる

Pit は加速足→遊脚期中期から加速

（遊脚期中期からぶん回しが入る）

ぶん回し歩行→遊脚初期から加速

Pit が入る要素：

けり足が強い人、ハイアーチ、甲高、サッカー、バスケ、ダッシュ、シンスプリント

前距腓靱帯が伸びると

外側部がプカプカし非荷重傾向になる



伸びた側の腰が痛くなったり、しびれたりする

非荷重系の立ち方



側方動揺歩行と一緒に
靴の外側が減る

検査をよりしやすい環境に整える為に

CGW の引き出し方

非荷重状態の時は関節がグラグラ、詰める為に行っていく
AP 後、股関節、膝関節、足関節がつまる



純粹に WB の症状を診ることができるようになる

中枢へ踵を 2～3 回叩いて関節を詰める



技法① 股関節 90 度屈曲し内転させて固いところで自重をかける (30 秒～)
反対側の脚も内旋させる (骨盤を安定させるため)

技法② SLR の肢位で足首を背屈させる → 膜の効果で足首、膝、股関節を
潤滑させる (30 秒～)

技法③ 股関節を中間位、軽度外転させて自重で潤滑させる (30 秒～)

Pit が及ぼすアーチの機能低下



A. 載距突起(アーチの頂点)が衝撃緩衝で要だが、Pit になるとアーチが崩れる



対応: 足首の整復、載距突起整復、ミスト、ローラー、MS

アーチが崩れることにより出てしまう影響

- ヒールストライクが強い（ガツガツ歩く）
- 母指が上がらない
- 後ろ重心
- ハイアーチ（**タコや角質ができる原因にもなる**）
- アーチがだんだん沈んでくる



AS の人が取りやすい足の姿勢

- 立っている時に足首を回外し、その恰好が楽だという人
- 立っている時に足首を外にむける（がに股姿）